

Fecha Última Actualización: 24-05-2022 7:49:02

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Gabriela Maria Godoy Bustamante
Edad : 63a 6m 4d
Dirección : Ancud 0895 Dpto. 15

Rut : 8.775.680-7
Fecha Nacto: 20/11/1958
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2109292
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 5592 5394

N° Epicrisis
307871

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Básica (4to Piso)

Fecha Ingreso : 26/04/2022 14:22

Días Estadía: 28

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 24/05/2022 07:05

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

compromiso estado general.

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

RESUMEN DE EGRESO
24/05/22

NOMBRE: Gabriela María Godoy Bustamante

RUT: 8775680-7

EDAD: 63 años

FECHA DE INGRESO HSR: 26/04/22

FECHA DE INGRESO UTIM: 27/04/22

CONTACTO: 944278211 Juan Paves (Esposo)

ANTECEDENTES:

· Mórbitos: DHC en estudio (Obs NASH) Child C Meld Na 17 pts, osb NASH; Dx en 2021 debut por HDA ligadas. Enfermedad del Tejido Conectivo en estudio LES vs Sx Sjogren (Dx LES en 2017 por cuadro de equimosis, rash violáceo y trombocitopenia, desde 2021 en control CDT Reumatología HSR plantean probable Sx Sjogren por marcadores inmunológicos ANA (+) > 1/1280 Patrón nuclear (-), citoplasmático (-) Mitótico parecido a NUMA (AC-26), C3 59 C4 13) Hipotiroidismo, DM2 NIR.

· Quirúrgicos: Colectectomía, Hernioplastia Umbilical

· Fármacos: Prednisona 7.5 mg/día, Hidroxicloroquina 200 mg/d, Levotiroxina 100 mcg/día, Propanolol 20 mg c/12 hrs, Lactulosa SOS; Furosemida 40-20 mg, Espironolactona 75 mg/día, Ac Ursodesoxicólico 500 mg c/12 hrs, Glibenclamida/Metformina 500/5mg recientemente suspendido (22/04/22).

· Alergias: (-)

· Hábitos: TBQ (ocasional) abandonado hace 6 meses, OH (ocasional), Drogas (-).

· Hospitalizaciones: Marzo- primera quincena de abril por celulitis en pierna izq (extrasistema)

· Social: vive con esposo e hijo.

· Funcionalidad: limitación a la movilización desde hace 3 meses por cuadro de edemas en EEII, limitación cognitiva por episodios de encefalopatía. ECOG 2

· Inmunizaciones: Familiar refiere 2 dosis de Sinovac

ANAMNESIS

Paciente con antecedentes descritos, quien familiar refiere desde el 25/04/22 episodios de hematoquecia en 2-3 oportunidades, moderada cantidad, evolucionando con astenia, hiporexia y dolor abdominal difuso, evoluciona en lapso de 6 horas aprox con somnolencia, por lo cual consulta en SU del CASR.

Fecha Epicrisis : 24/05/2022 07:49

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 24-05-2022 7:49:02

Página 2 de 4

Ingresar al SU en malas condiciones generales, comprometida de consciencia, se pesa HGT 50 mg/dl, hipotensa (87/38 mmHg) SatO2 92%. Administran 3 amp de sol Dext 30% con estabilización de HGT.

Lab de Ingreso: HB 11/ HTO 36, Leu 6760, Pla 121000, PCR 164, Bil T 5.0, FA 135, TGO 137, TGP 118, LDH 284, Albúmina 2.2, PH 7.29, PCO2 37.8, HCO3 18.1.

Citoquímico de líquido ascítico: Aspecto turbio, Prot 5.9 g/l, Glu 36 mg/dl, Rcto Cel 8640, PMN 64%, MN 36%, ADA 11.7, Cultivo de liq Ascítico + E. Coli (pendiente tipificación). Sedimento Urinario no inflamatorio, UC (-). PCR SARS COV 2 (-).

TC Abdomen y Pelvis sin contraste= Cambios morfológicos compatibles con DHC, sin evidencia de lesiones de aspecto agresivo. Bazo aumentado de tamaño 15.1cm, imagen sugerente de engrosamiento parietal del colon transverso, sigmoides y recto, no caracterizable. Acentuada ascitis.

TC Extremidad Inferior Izq= Acentuado edema del tejido celular subcutáneo que predominan en la pierna en su aspecto antero medial donde se observan una probable flictena. No hay burbujas de gas que sugieran una fascitis necrotizante. Grupos musculares de trofismo conservado con signos sugerentes de edema

Se traslada a UTIM para seguimiento y manejo.

Evolución Intrahospitalaria en UTIM:

HDN: al ingreso leve tendencia a la taquicardia, VEC mal distribuido, ascitis importante. BH con tendencia a la positividad, oligoanúrica, por lo que en contexto de PBE se difiere manejo diurético. En tanto, por caída de hb e historia de hematoquecia completa protocolo de Terlipresina +3 (26/04- 29/04) por planteamiento de HDA. EDA del 29/04/22 sin evidencia de sangrado. En tanto, por deterioro de función renal, requerimiento de HD, completa hasta el 01/05/22 protocolo de Terlipresina por planteamiento de SHR.

En lo sucesivo evoluciona con hemodina autosostenida, sin requerimientos de DVA, sin embargo el 19/05/22 presenta caída de HB 7.5->6.1, elevación de láctico hasta 78 en relación a exteriorización de sangrado (melena abundante) con compromiso de perfusión periférica e hipotensión sostenida, por lo que se TX 02 uds CG, 06 Contrado Plaquetario y 06 uds de PFC. Se inicia soporte con NE 0.1 mcg/Kg/m, manteniendo PAM 60-65 mmHg.

VENT: ha estado con requerimientos intermitentes de O2 en contexto VEC aumentado (mal distribuido) ascitis persistente pese a TRR y paracentesis evacuadora (10/05). Sin posibilidad de uso de diuréticos por AKI. 19/05/22 evoluciona con shock hipovolémico, compromiso de consciencia, progresión de encefalopatía por lo que se decide protección de vía aérea. 19/05/22 a las 11am aprox, se procede a IOT por SIR (Fentanil 100 mcg/Etomidato 20 mg + Rocuronio 50 mg EV) laringoscopia evidencia abundante contenido hemático coagulado a nivel de vía aérea superior, se posiciona TOT #8.0 a 23 cm de arcada dental y se conecta a VMI con parámetros VT 340/ PEEP 6/ FR 20/ FIO2 50%.

ETE: TVP femoral izquierda subaguda, con anticoagulación suspendida por TTPK espontáneamente prolongado y difícil de titular, además de trombocitopenia severa, se anticoaguló durante 72 horas 18/05-20/05/22 sin embargo por progresión de trombocitopenia y alto riesgo de sangrado se suspendió. Ecoabdominal 18/05/22, señal doppler Vena Porta Permeable. Se plantea en contexto de TVP previa, prolongación de TTPa, trombocitopenia y consumo de fibrinógeno, probable coagulopatía de consumo, ameritando Tx de Crioprecipitado, PFC y Plaquetas.

Renal: al ingreso con AKI KDIGO III, con índices urinarios compatibles con prerenalidad. Respuesta a manejo con albúmina, se planteó probable SHR, había logrado suspender HD de agudos. Desde el 06/05 oligúrica, con tendencia a elevación de azoados, reinició HD 09/05. Cuenta con SOC no concluyente de signos GMN, sin embargo evoluciona con tendencia a la Leucopenia, Linfopenia, Trombocitopenia severa, ante C3-C4 consumido (mediciones del 03/05 y 10/05) proteinuria 1.2 g/24 hrs (06/05) se discute con Nefrología planteándose compromiso en contexto de probable actividad lúpica. Se define en concordancia con Reumatología pulsos de MTP; paciente con requerimiento de Bx Renal para definir etiología (SHR vs Compromiso renal por LES) pero en contexto de coagulopatía se difiere de momento.

Gastro/Hepático: DHC sin etiología clara, probablemente un NASH vs AHAI. Al estudio: AgHbs NR, HCV NR, AMA (-), ASMA (-), ANA (+) 1:1280, IgM 383, sin biopsia.

-Ascitis: GIII. paracentesis evacuadora 10/05 (2700 cc), no inflamatorio, con cultivo pendiente a la fecha se mantiene (-). A pesar de HD, reincide ascitis GIII; manejo refractario por lo que se drena el 10/05 (3lts) y el 15/05 (7 litros) + reposición de albumina, citoquímico de líquido ascítico en ambos drenajes no inflamatorio.

-SHR: AKI Kdigo III en HD. Al ingreso se manejó con terlipresina/albumina, luego con NA, sin respuesta. Pese a ello, tiene FENa y FE BUN sugerentes de pre renalidad y respondió al uso de albúmina, sin embargo presenta nuevo deterioro de función renal, requiriendo reinicio de HD agudos desde el 09/05, en relación a hipervolemia y ascenso de azoados. Destaca que en

Fecha Epicrisis : 24/05/2022 07:49

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 24-05-2022 7:49:02

Página 3 de 4

relación antecedente de LES, marcadores de actividad, que hacen suponer jugar actualmente un rol descompensante por sobre elementos de SHR. Cuenta con estudio FeNa, FeBUN sugerentes de prerenalidad, sin embargo poca utilidad en contexto de paciente en HD.

-VE: sin HDA, EDA (29/04) con VE pequeñas. 19/05 Melena, compromiso HDN, se inicia soporte con NE + IBP en dosis altas y se solicita nueva EDA.

-EH: desde el 16/05/22 con deterioro progresivo de consciencia, evoluciona con EH GIII, a pesar de ritmo regular de deposiciones, adicionándose manejo con Rifaximina, TC Cerebro del 17/05 sin evidencia de lesiones estructurales (sangrado, edema, isquemia) que orienten otra causa de compromiso de consciencia.

-HCC: Sin lesiones focales.

En seguimiento por equipo de Hepatología, paciente en plan de Tx Hepático. Se solicita ecoabdominal con Doppler portal (18/05) sin evidencia de trombosis portal. Grupo ABO ORh+. (p) Ecocardiograma TT. En seguimiento por especialidad.

REUMATO: LES desde 2017 en seguimiento en el extrasistema, con control en CDT desde 2021, describiendo xerostomía y ojo rojo frecuente. Cuenta con perfil autoinmune del 02/22:

-C3 77 (VR 83-193) C4 14 (VR 15-57)

-IgA 1627 (VR 70-400), IgM 308 (VR 40-240) IgG 2003 (VR 700-1600)

-FR <10, ANCA (-), Anti DNA (-), ANA 1:1280 patron mitótico parecido a NUMA AC-26, perfil SAF (-), Perfil ENA (-).

Se planteó un probable Sjögren, pero cuenta con gammagrama de g. salivales (feb 2022) normal. Se mantuvo tto PDN 7.5 mg/día e Hidroxicloroquina 200 mg/día.

Actualmente cursa con una trombocitopenia severa + anemia + leucopenia con linfopenia, AKI no del todo explicada por su cirrosis (posible nefropatía lúpica vs sepsis vs contraste) Sedimento Urinario Compuesto (04/05) confundente por elementos infecciosos, UC polimicrobiano, perfil reumatológico:

-03/05: C3 (29) y C4 (5) consumidos. Recuento de IgG (773), IgA (522), IgM (120) normal, anti DNA (-), Perfil ENA (-) y perfil SAF (-).

-10/05: C3 (27) C4 (5). Discutido con Reumatología, en contexto autoinmune de antecedente de LES, cursar actualmente con coagulopatía de consumo, trombocitopenia severa, leucopenia, linfopenia y sedimento urinario dudosamente inflamatorio, elevación de LDH hasta 549 (hemograma sin esquistocitos), reticulocitos aumentados (3.5%) se propone pulsos de MTP en dosis bajas 250 mg (tres pulsos), que completa del 12/05- 14/05, posterior traslape a PDN 40 mg/día. Evoluciona con persistencia de trombocitopenia, LDH peri 300, Hiperbilirrubinemia indiferenciada, no del todo explicado por daño hepático, Coombs Directo del 17/05 3+. 18/05/22 reevaluada por Reumatología, quienes sugieren ante evidencia de actividad autoinmune, hemólisis autoinmune, trombocitopenia, leucopenia, linfopenia y consumo del complemento (no del todo claro si por DHC y/o actividad autoinmune) nuevo pulsos de MTP 3x 500mg/día, sin embargo por shock hipovolémico hemorrágico se difiere y se inicia manejo con Inmunoglobulina G EV 70 g/día, que inicia hoy.

Renal: al ingreso con AKI KDIGO III, con índices urinarios compatibles con prerenalidad. Respuesta a manejo con albúmina, se planteó probable SHR, había logrado suspender HD de agudos. Desde el 06/05 oligúrica, con tendencia a elevación de azoados, reinició HD 09/05. Cuenta con SOC no concluyente de signos GMN, sin embargo evoluciona con tendencia a la Leucopenia, Linfopenia, Trombocitopenia severa, ante C3-C4 consumido, proteinuria 1.2 g/24 hrs (06/05) se discute con Nefrología planteándose compromiso en contexto de actividad lúpica. Se define en concordancia con Reumatología pulsos de MTP, los cuales posterior cumplimiento no mejora, siendo reevaluada el 18/05 definiendo manejo con Inmunoglobulina G EV. A la espera de mejoría de condiciones generales y coagulación para eventual Bx renal.

Infeccioso: Cursó con PBE - panproctocolitis, con aislamiento de E. Coli en ascitis del 26/04, completó 7 días de ceftriaxona, buena evolución clínica (paracentesis de control no inflamatoria, cultivo neg). 06/05 EO inflamatorio, UC polimicrobiano, se define cobertura con Tazonam (hoy +8d). Por antecedente de Celulitis en EII, se amplió cobertura con Vancomicina (hoy +4d). TC EII 13/05 sin elementos de fascitis, solo compromiso por edema subcutáneo. PCR estática peri100, se plantea asociada a actividad autoinmune. Por ausencia de elementos de infección activa suspendo cobertura ATB, desde el 15/05/22 profilaxis PCP y PBE (ciprofloxacino enteral). 19/05/22 deterioro clínico, no protección de vía aérea, se evidencia abundante contenido de restos hemáticos en vía aérea, se plante cuadro de Neumonía Aspirativa, por lo que se pancultiva: HMC periféricos, arrastre de CHD, cultivo de pta CVC yugular derecho, EO y UC. Caet no tomado por restos hemáticos abundantes.

DX de eGRESO

FALLA MULTIORGANICA..

Shock Hipovolémico Hemorrágico:

HDA Variceal con compromiso HDN.

Insuficiencia Respiratoria Aguda

Fecha Epicrisis : 24/05/2022 07:49

Página 3 de 4

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 24-05-2022 7:49:02

Página 4 de 4

Neumonía Aspirativa
DHC por probable NASH Child C/MELD NA 46 pts, descompensado
PBS E coli tratada
Panproctocolitis
EH GIV
AKI K DI GO III c/ TRR
Ob s SH R vs nefropatía lúpica
Coagulopatía de consumo - CID
Pancitopenia: Anemia Coombs Directo +, Trombocitopenia y Leucopenia (Linfopenia)

Trombosis venosa profunda del la v. femoral izquierda
Celulitis en EI
AM-> LES, Hipotiroidismo y DM2 NIR.

24/05/22 PACIENTE EN CONDICIONES GRAVES, PRESENTA PARA CARDIORESPIRATORIO FALLACIENDO A LAS 7:44 AM-

Diagnóstico de Egreso

HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

FALLECE

Plan Post Alta

FALLECE

Indicaciones

Tipo de Reposo :

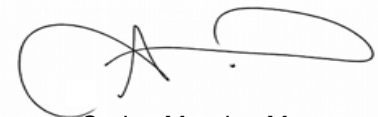
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Carlos Morales Mora

Médico Tratante (Staff)